本章数字资源

第二十一章 焦虑障碍的全科医学处理

学习提要

- 焦虑障碍是人群中最常见的精神障碍之一，在综合医院及基层医疗卫生机构就诊的患者中，焦虑障碍十分常见，需要全科医生进行准确的识别、诊断及鉴别诊断。
- 广泛性焦虑障碍是一种常见的焦虑障碍，其症状泛化、多变、波动，病程多呈慢性，其反复发作与遗传因素、个性特点、认知过程、不良生活事件、人际关系等均有关系。作为全科医生，应抓住其诊疗过程中的要点：临床表现、问诊思路、体格检查要点（一般体格检查，精神状况查体）、相关的辅助检查、心理量表的选择及评估方法、治疗策略［包括药物治疗及非药物治疗（生物反馈、身体锻炼、认知行为疗法）］、健康宣教、转诊指征。

焦虑（anxiety）是一种内心紧张不安，担心或者预感到将要发生某种不利情况，同时感到难以应对的不愉快情绪体验。在日常生活中，当人们面对潜在或真实的危险或威胁时，焦虑是防御性情绪，激励个体积极行动，取得更好的结果。病理性焦虑（pathological anxiety）又称焦虑症状，是指无明确的致焦虑因素，或刺激和反应不对称，反应严重或持续的焦虑反应，常伴有憋气、心悸、出汗、肌紧张性震颤、尿频等自主神经功能紊乱症状。

焦虑障碍（anxiety disorder）又称焦虑症，是一种以上述病理性焦虑情绪症状为主，伴有强烈的自主神经系统症状和运动不安为特征的神经症，病程多迁延反复，严重可致精神残疾，给患者和家庭带来巨大痛苦。焦虑障碍是人群中最常见的精神障碍之一，包括广泛性焦虑障碍、恐怖性焦虑障碍（社交恐怖、广场恐怖和特定的恐怖等）、惊恐障碍（又称急性焦虑障碍）等。根据 2019 年中国精神卫生调查（China Mental Health Survey，CMHS），焦虑障碍终身患病率约为 7.6%，其中，受教育程度较低者和收入水平较低者的焦虑障碍患病率较高。

知识点

焦虑障碍的发病原因

目前，焦虑障碍病因尚不清楚，可能与多种因素有关，主要有：①人格基础：以多愁善感、敏感、情绪化，容易忧虑、古板、保守、孤僻等情绪不稳定或性格内向的人多见；②社会心理因素：常为诱发因素，呈非特异性，如要作出重要决定时，人们需要为此作出调整，当这种调整超出正常的适应能力，或超出可承受限度，就可导致焦虑；③遗传因素：研究发现同卵双生子惊恐障碍的同病率高于异卵双生子。

知识点

焦虑障碍的临床表现

焦虑障碍分为惊恐发作和广泛性焦虑障碍：①惊恐发作即急性焦虑障碍，患者在日常生活、工作、学习中，突然出现强烈的窒息感、濒死感和精神失控感，同时伴有严重的自主神经功能失调，如胸痛、胸闷、心悸、呼吸困难等，部分表现为过度换气、头晕、多汗、颤抖、手足麻木、胃肠不适

等症状。发作历时短，一般为 5~10 分钟，很少超过 1 小时，可自行缓解。发作过后患者仍心有余悸，担心再次发病时得不到及时的帮助，因而自动回避一些活动，如不愿单独出门。②广泛性焦虑障碍又称慢性焦虑，是焦虑障碍最常见的表现形式。经常的或持续的无明确对象或固定内容的紧张不安，或过分担心现实生活中某些问题，整日处于大祸临头的模糊恐惧和高度警觉状态，常伴搓手顿足、来回走动、坐立不安等运动性不安症状，以及心悸、出汗、胸闷、喘息、手抖、尿频等自主神经功能紊乱症状，甚至出现阳痿、早泄、月经不调，患者注意力难以集中，有时感到脑子一片空白。

焦虑障碍的临床表现包括多种精神心理症状以及躯体症状，包括但不限于以下几点。

1. 唤起　过分警觉、精神紧张不安、惊跳反应增强。

2. 情绪症状　恐惧、忧虑。

3. 思维症状　非现实性地评估自身或他人所遇危险。

4. 行为表现　目的行为受限，运动性不安（无目的小动作），回避可能增强不安全感的处境。

5. 躯体症状　①过度换气：昏厥、感觉异常、手足搐搦；②肌紧张：疲劳、疼痛、僵硬、颤抖；③自主神经活动增强：心悸、面色苍白、口干、腹泻、出汗、尿频；④其他：胸骨压榨感等。

6. 其他相关症状　人格解体（感觉自己或周围环境不真实）、继发情绪低落等。

临床案例

主观资料（S）：患者，男性，36 岁。因“反复胸闷、心悸及失眠、多梦 1 年”至全科门诊就诊。

【问题 1】作为一名全科医生，根据患者目前的症状，从生物-心理-社会因素角度应获取哪些信息？

思路 1：首先从生物学角度，了解患者是否存在心血管系统、呼吸系统等躯体疾病，如冠心病、心律失常、肺栓塞等。在进行病史采集时，应当关注患者的主要症状、伴随症状及需要鉴别的症状，既往就诊情况及结果，同时了解是否有高血压、糖尿病等病史，有无吸烟等不良嗜好。

思路 2：该患者是青年人，独自到全科门诊就诊，没有家属陪同，可能是患者不愿意别人知道自己目前的病情，同时对于自己病症的反复发作比较苦恼，自觉难以解决。患者主动寻求全科医生的帮助，表明患者有一定的自知力，认识到自己目前的症状是一种疾病状态。对于来诊的青年人群，在考虑器质性疾病的前提下，不能忽视患者的心理问题及心理疾病存在的可能性，必要时应进行相关心理量表评估。

思路 3：患者处于青年阶段，考虑到目前社会生活节奏快的现状，可能工作、生活等压力因素也间接导致了患者反复出现上述症状。所以要仔细询问患者的工作、生活情况，评估患者是否受社会因素的影响。

临床病例

主观资料（S）：患者，男性，36 岁。因“反复胸闷、心悸及失眠、多梦 1 年”至全科门诊就诊。通过追问病史，了解到以下情况。

现病史：1 年前，患者工作调动后，开始反复出现胸闷、心悸，与活动、劳累无关，多在夜间出现，每次持续半小时至 2 小时不等，可自行缓解，无前胸及后背疼痛，无喉部紧缩感，无恶心、呕吐等不适，近 1 年来常有失眠、多梦。担心自己有严重的心血管疾病，曾多次发作后在门诊检查心肌酶、肌钙蛋白、心电图等，未见异常。半年前于外院行冠状动脉 CTA 检查未见明显异常。发病以来，神志清，精神欠佳，饮食可，失眠、多梦，大小便正常，近期体重无明显变化。

既往史：否认高血压、糖尿病、心脏病、肾病病史；否认肺结核、病毒性肝炎及其他传染病；无食物、

药物过敏史；无外伤、手术、输血史；无中毒史；无长期用药史。疫苗接种史不详。

个人史：吸烟 10 余年，每天 10 支。饮酒 8 年，4~5 次/周，饮白酒 3~4 两/次，无毒物及放射性物质接触史。

婚育史：未婚未育。

家族史：父故于急性心肌梗死，母体健，1 妹，体健。

【问题 2】该患者的病例特点是什么？

思路：青年男性，慢性病程；反复夜间胸闷、心悸 1 年，每次持续半小时至 2 小时不等，可自行缓解，伴有失眠、多梦；心脏相关检查未见明显异常；工作压力大，担心自身出现严重疾病；父亲故于急性心肌梗死。

【问题 3】该患者可能的病因是什么？

思路 1：该患者长期吸烟，父亲因急性心肌梗死去世，有心脑血管疾病的危险因素；存在反复胸闷、心悸等症状，但是症状持续时间超过半小时，无明显诱因，可自行缓解，不符合心绞痛的典型症状；发作后反复检查心肌酶、肌钙蛋白、心电图未见异常，半年前于外院行冠状动脉 CTA 检查未见明显异常，说明没有明显的心肌细胞损伤和冠状动脉狭窄。综上，该患者暂不考虑心血管疾病。

思路 2：该患者症状常在夜间发作，与活动、劳累无关，无前胸及后背疼痛，无喉部紧缩感。首先，无与活动、劳累相关的心血管系统疾病的诱因；其次，没有典型胸痛的症状。但患者伴有失眠、多梦，这提示患者的症状可能是心理因素所致。

思路 3：患者父亲曾经因急性心肌梗死去世，可能对患者本身造成一种心理暗示，担心自己患冠心病风险较大，但患者多次实验室检查及冠状动脉 CTA 检查均未发现异常，又加重了患者的这种焦虑状态，担心与现实事件不符，这些症状持续半年以上，结合患者的病史，考虑可能是焦虑障碍的躯体化表现。

知识点

广泛性焦虑障碍（generalized anxiety disorder，GAD）的临床表现

1. 精神性焦虑　过度担心是精神性焦虑的核心症状。表现为经常担心未来可能发生的、难以预料的某种危险或不幸。有的患者经常莫名地处于一种提心吊胆、惶恐不安的强烈内心体验中，却不能明确担心的对象或内容，称为自由浮动性焦虑。有时患者担心的是现实生活中可能发生的事情，这种紧张情绪与现实很不相称，使患者感到难以忍受，但又无法摆脱。警觉性增高也是精神性焦虑的常见症状，表现为易惊吓，对外界刺激易出现惊跳反应；同时有注意力难以集中、入睡困难、易醒、易激惹等。

2. 躯体性焦虑　包括运动性不安与肌肉紧张。运动性不安可表现为搓手顿足、静坐不能、不停地来回走动、无目的的小动作。肌肉紧张表现为主观上的一组或多组肌肉不适的紧张感，严重时有肌肉酸痛，多见于胸部、颈部及肩背部肌肉，有的患者可出现肢体的震颤、语音发颤。

3. 自主神经功能紊乱　表现为心悸，胸闷气短，头晕，头痛，皮肤潮红、出汗或苍白，口干，吞咽梗阻感，恶心，胃部不适，腹痛，尿频等。有的患者可出现早泄、勃起功能障碍、月经紊乱、性欲减退等症状。

4. 其他症状　GAD 患者常合并疲劳、抑郁、强迫、恐惧、惊恐发作、人格解体等症状体验。

【问题 4】完成病史采集后，下一步应重点进行哪些体格检查？

思路：须测量心率、血压、脉搏、呼吸频率，重点在于完成心脏的体格检查。此外，还应对患者完成精神状况查体。

NOTES

知识点

心脏体格检查的注意事项

视诊时，患者取卧位，医生视线与胸廓同高。

触诊心包摩擦感时，应在心前区或胸骨左缘第 3、4 肋间触诊，若触到摩擦感，须嘱患者屏住呼吸，与胸膜摩擦感鉴别。

叩诊顺序：先左后右，从下到上，从外到内。右侧先叩出肝上界，在肝上界的上一肋间进行叩诊。

听诊顺序：从二尖瓣区开始，依次进行肺动脉瓣区、主动脉瓣区、主动脉瓣第二听诊区、三尖瓣区的听诊。

对于疑似心理障碍的患者，在进行精神状况查体时往往容易忽视某些重要内容。重点应从以下几个方面进行检查：一般表现、认知活动、情感活动、意志行为活动以及自知力。

临床病例（续）

客观资料（O）：

一般体格检查：体温 36.8℃，脉搏 85 次/分，呼吸 21 次/分，血压 135/86mmHg。神志清，精神欠佳，全身皮肤黏膜及巩膜无黄染，浅表淋巴结未触及肿大。颈软，伸舌居中，双侧瞳孔等大等圆，直径约 3mm，对光反射灵敏，双眼球各方向运动充分，眼震阴性。双肺呼吸音清，胸廓无畸形。心前区未见异常搏动，各瓣膜区未触及震颤，心率 85 次/分，心律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音及额外心音，未闻及心包摩擦音。腹软，无压痛、反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常，移动性浊音阴性。四肢肌力、肌张力正常，双侧深浅感觉正常。病理征阴性，脑膜刺激征阴性。

精神状况查体：①一般表现：意识清晰，定向完整，接触主动，配合检查，衣着整洁，年貌相符，日常生活自理。②认知活动：问话有答，回答切题，语速、语量正常，定向力、记忆力及计算力均正常，未引出妄想等思维内容障碍。③情感活动：表情忧虑，情感反应与思维内容相协调；容易激动，反复询问自己是否是冠心病，是否存在猝死可能。④意志行为活动：兴趣减退，精神欠佳，无冲动打人及毁物行为，无自杀想法及违拗症状，有部分重复语言。⑤自知力：完整，主动要求治疗。

实验室检查：血常规：血红蛋白 120g/L。心肌酶谱：乳酸脱氢酶 120IU/L，天冬氨酸转氨酶 32IU/L，肌酸激酶 100IU/L，肌酸激酶同工酶 15IU/L。肌红蛋白：20μg/L。肌钙蛋白：0.1μg/L。D-二聚体：0.3mg/L。

心理评估：广泛性焦虑障碍 7 项量表（Generalized Anxiety Disorder-7，GAD-7）评分 15 分。

【问题 5】结合上述客观资料，为明确诊断应进一步完善哪些检查？

思路：该患者为青年男性，结合临床表现、体格检查和实验室检查等，须与心血管疾病鉴别，可以进一步完善心脏彩超、24 小时动态心电图及平板运动试验，必要时可考虑完善心肌核素显像，评估心肌细胞代谢情况，排除心肌病的可能。此外，患者有心悸症状，建议完善甲状腺功能及甲状腺彩超，评估是否存在甲状腺功能亢进。

知识点

胸闷、心悸症状需要完善的辅助检查

1. 实验室检查　心肌酶、肌红蛋白、肌钙蛋白有助于诊断或排除心肌梗死等；脑钠肽有助于诊断或排除心力衰竭；血常规可评估是否存在贫血及其他血液系统疾病；凝血功能及 D-二聚体有助于评估是否存在血栓性疾病；甲状腺功能测定可评估是否存在甲状腺功能亢进。

2. 超声检查　心脏超声可对患者心脏瓣膜及室壁运动功能进行检测，同时可以评估是否存

在心力衰竭。怀疑甲状腺疾病时，应完善甲状腺超声检查。怀疑存在下肢静脉血栓时，应完善下肢静脉彩超。

3. 24 小时动态心电图及平板运动试验　24 小时动态心电图有助于评估和判断临床症状与心脏电活动的关系。通过分析心律失常并进行危险评估，可以更准确地诊断心肌缺血，协助诊断冠心病，并鉴别心绞痛的类型。此外，还可以预测各类心脏疾病可能出现的恶性心律失常。平板运动试验是通过逐步加大运动量来测定患者心脏功能和运动耐力的一项检查，可用于协助诊断不明原因的胸痛，早期检出高危患者中的隐匿性冠心病，了解各种和运动有关的症状（如晕厥、心悸、胸闷等）的病因，了解运动引起的心律失常等。

4. 心肌核素显像　是利用心肌细胞的摄取特点，将放射性核素（也称医学显像剂）药物静脉注射到患者体内，待核素被心肌细胞摄取后，通过单光子发射计算机断层成像（SPECT）或正电子发射断层成像（PET），探测核素发出的信号（γ 射线）进行诊断。其中使用较广泛的是 SPECT 心肌灌注显像，属于无创检查，仅使用安全剂量的放射性显像剂，是一种安全、可靠、高效的影像学诊断技术。心肌灌注显像对冠心病的筛查、危险分层、疗效评价等方面具有重要价值。

【问题 6】该患者为什么选择 GAD-7 进行临床心理评估？

思路：通过病史考虑该患者有病理性焦虑症状，应当进行心理筛查评估。GAD-7 是一种广泛使用的心理紧张筛查自评量表，主要用于评估个体是否存在常见的广泛性焦虑障碍，有助于发现潜在的焦虑问题，为进一步的诊断和治疗提供依据。该量表包括 7 个问题，每个问题有 4 个选项，针对过去两周的状况进行评估，简单易行，便于门诊实施。该患者 GAD-7 评分 15 分，提示存在重度焦虑。

知识点

焦虑障碍常用的评估量表

临床上除了 GAD-7，自评量表常用的还有宗氏焦虑自评量表（Zung Self-rating Anxiety Scale，SAS）和状态-特质焦虑问卷。此外，还有医生评估时常用的汉密尔顿焦虑量表（Hamilton Anxiety Scale，HAMA）。

1. 宗氏焦虑自评量表　SAS 是一个含有 20 个项目的自评量表，用于评定焦虑的主观感受及其在治疗中的变化，评定时间为最近 1 周。SAS 采用 4 级评分，主要评定项目为所定义的症状出现的频度。所有项目得分相加即得总分，总分 >40 或标准分超过 60 即可判定有焦虑情绪。SAS 适用于具有焦虑症状的成年人，具有较广泛的适用性。SAS 能较准确地反映有焦虑倾向的患者的主观感受，可作为门诊了解焦虑症状的主要自评工具。

2. 状态-特质焦虑问卷　该量表共 40 个条目，分为评定状态焦虑（S-AI）和特质焦虑（T-AI）2 个分量表，4 级评分。该量表内容简明，操作方便，分别评定状态和特质焦虑，优于其他焦虑量表，易被测试者接受和掌握。

3. 汉密尔顿焦虑量表　是经典的焦虑他评量表，应用较为广泛。该量表包括 14 个条目，采用交谈与观察相结合的方式评定患者的主观体验，可以评定患者最近 1 周的焦虑状况，分为 4 级评分，同时可用于患者的疗效评估。分为躯体性和精神性两大类因子结构，总分能够较好地反映病情严重程度，一般≥14 分为肯定有焦虑，≥21 分为肯定有明显焦虑，≥29 分可能为严重焦虑。

【问题 7】该患者诊断考虑是什么？

思路：该患者反复出现胸闷、心悸伴有失眠、多梦 1 年，辅助检查心电图、心肌酶及肌红蛋白+肌钙蛋白未见异常，结合既往冠状动脉 CTA 检查未见明显异常，提示心脏无明显器质性病变。一般体格检查未见异常，精神状况查体提示患者意识清晰，认知活动正常，情感活动显示患者表情忧虑，容易激

NOTES

动，意志行为活动正常，同时患者自知力完整，考虑患者存在明显的心理性焦虑，GAD-7 评估提示存在重度焦虑，也支持这一判断。故患者的诊断考虑为：广泛性焦虑障碍。

知识点

广泛性焦虑障碍诊断要点

1. 在至少 6 个月内的多数时间对许多方面（如工作、学习表现）的显著焦虑和担忧，并且很难控制。

2. 至少存在 3 个［精神障碍诊断与统计手册第 5 版（DSM-5）］或 4 个［国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）］躯体症状：不安或紧迫感、易疲劳、难以集中精力、易怒、肌肉紧张、睡眠障碍（入睡困难或一直困倦或睡眠质量不满意）或自主神经功能紊乱。

【问题 8】针对该患者的治疗策略有哪些？

思路 1：对于广泛性焦虑障碍的患者来说，治疗目标为缓解或消除焦虑症状及伴随症状；恢复患者社会功能，提高生命质量；预防复发。在治疗之前，应当首先评估其焦虑的严重程度，根据患者疾病的严重程度，进行综合、全病程、个体化治疗。该患者 GAD-7 评分 15 分，为重度焦虑。

思路 2：广泛性焦虑障碍与遗传因素、个性特点、认知过程、不良生活事件、人际关系等均有关系。该患者各种症状发生在工作调动之后，焦虑症状的产生可能与工作压力有关，且对自身症状过度担心，应当注意消除这些因素。

思路 3：药物治疗是广泛性焦虑障碍的主要治疗方法。该患者重度焦虑，且存在失眠、多梦症状，可以选择选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（selective serotonin reuptake inhibitors，SSRIs）联合苯二氮䓬类药物，起到抗焦虑、助眠作用。

知识点

广泛性焦虑障碍的药物治疗

治疗广泛性焦虑障碍的常用药物有三种：①作用最温和的 5-羟色胺 1A 受体部分激动剂，如丁螺环酮、坦度螺酮等，可以激活中枢神经 5-羟色胺神经元的 5-羟色胺 1A 受体，抑制 5-羟色胺神经递质的转换，同时可以抑制应激反应导致的血浆肾素活性升高，从而改善心理负担导致的胃溃疡和食欲减退等。通常用于广泛性焦虑症的治疗，对于焦虑伴有轻度抑郁症状者有效。然而，对于严重焦虑伴有惊恐者疗效不佳，且不适用于焦虑伴有严重失眠的患者。②选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂，包括号称“五朵金花”的氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明以及西酞普兰。这类药物通过抑制 5-羟色胺的再摄取，提高 5-羟色胺在突触间隙的浓度，增强 5-羟色胺的功能，实现抗焦虑的作用。③具有抗焦虑、镇静、催眠作用的苯二氮䓬类药物，包括阿普唑仑、劳拉西泮、氯硝西泮等。这类药物可以影响 γ-氨基丁酸功能、降低神经兴奋性，从而实现镇静、安定、抗焦虑的作用。

思路 4：非药物治疗是广泛性焦虑障碍的重要辅助治疗方法。在药物治疗的同时，可以采用生物反馈、放松训练、电针、身体锻炼等措施增强治疗效果。此外，可以进行多种形式的心理治疗，如最有证据支持的是认知行为疗法（cognitive behavioral therapy，CBT）。这种治疗方式旨在减少患者的消极解释，用应对行为替代避免行为，并降低紧张和自主觉醒水平。该患者因其父亲有心肌梗死就怀疑自身的胸闷为冠心病，存在错误认知，应对其进行相关健康教育。

知识点

认知行为治疗

1. CBT 的基本过程　①对患者进行教育。②指导、培训患者控制症状、放松和控制呼吸的基本技能（尤其是过度换气的患者）。③识别、挑战和改变一些不适宜的想法、情感、观念和行为。

2. CBT 的基本原则和目标 ①给患者生活带来如其所期望的改变，让患者的想法更现实，更能适应现实环境。②评判、监控和力图修正不良想法和行为。③鼓励积极的行为，阻止消极的行为。④针对患者对疾病的错误理解、认识进行教育。⑤鼓励患者成为积极的参与者，而不是消极的接受者。⑥列出一个问题清单，并注明问题的主次。

临床病例（续）

处置计划（P）：①建议完善 24 小时动态心电图，同时完善甲状腺功能及甲状腺彩超，必要时完善平板运动试验。②可进行补充心理量表评估。③为患者分析病情及讲解相关健康知识。④给予舍曲林改善焦虑，暂予劳拉西泮改善睡眠。⑤必要时转入心理医学科进行干预治疗。

【问题 9】 针对该患者，全科医生健康教育包括哪些方面？

思路 1：向患者解释目前病情，减轻患者对于自身病情的过度忧虑，减轻患者的心理负担。

思路 2：指导患者改善不良的生活方式，减少心脑血管疾病的危险因素，同时改善焦虑症状。鼓励患者戒烟限酒，作息规律，适当运动，拓展兴趣爱好，转移注意力。

思路 3：鼓励患者规律用药，按时服药。注意向患者解释药物起效时间、疗程、可能发生的不良反应及应对策略。舍曲林的药物累积往往较慢，临床往往需要连续服用 2~3 周才能起到明显效果，所以早期在药物症状起效前应坚持服药，避免频繁换药，同时应当规律监测肝、肾功能。服用劳拉西泮片后可能会出现嗜睡、乏力、头晕、食欲减退等不良反应，一般不需要过多担心，可自行缓解。

思路 4：虽然焦虑障碍相对于精神分裂症、抑郁症来说，安全风险较低，但是焦虑障碍常伴有不同程度的抑郁症状。该患者自行就诊，且父亲因病去世，全科医生应当积极与家属进行沟通，评估患者是否存在自杀想法、企图或行为，如有上述情况，应尽快转诊至上级精神卫生医疗机构。

知识点

焦虑障碍的转诊指征

患者出现以下情况时，应当转诊至心理专科或者精神卫生医疗机构：①曾经有焦虑障碍发病史，目前的情绪障碍仍较显著；②精神症状严重，单一抗焦虑药物难以控制；③焦虑反复发作，不易缓解；④酒精或药物滥用明显；⑤18 岁以下儿童或青少年患者或者是老年患者合并严重的器质性疾病；⑥围产期或哺乳期女性患者；⑦抗焦虑药物治疗依从性差；⑧虽然焦虑障碍较轻，但患者的社会功能受损较严重。

（王留义）

思考题

1. 作为全科医生，临床上遇到一个焦虑障碍患者该如何问诊？
2. 广泛性焦虑障碍患者的临床表现有哪些？
3. 作为基层的全科医生，焦虑障碍的患者转诊指征有哪些？

思考题解题思路　本章目标测试　本章思维导图